BONUS 1

Banka od 200 zaključaka opisa

200 gotovih rečenica za Zaključak / Dojam za normalnu pretragu, incidentalni nalaz i hitni nalaz, razvrstanih po modalitetu i sustavu. Zaključite svoj opis jednom jasnom rečenicom iz koje čitatelj zna što treba učiniti.

Sadržaj

Kako napisati zaključak opisa

RTG — 50 rečenica

CT — 70 rečenica

MR — 35 rečenica

UZV / Doppler — 45 rečenica

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako napisati zaključak opisa

Korak SAŽMITE: odgovor na kliničko pitanje, najvažniji nalaz na prvom mjestu, po potrebi preporuka i obavijest.

> *Većina kliničara najprije čita Zaključak. Koliko god nalazi bili dobri, ako je Zaključak nejasan, opis ostaje nepotpun.*

1. **Najprije odgovorite na kliničko pitanje** — ako je pitanje glasilo «apendicitis?», prva rečenica mora reći postoji li apendicitis ili ne.
2. **Poredajte prema važnosti** — hitni nalaz uvijek je na prvom mjestu; incidentalni nalazi na samom kraju.
3. **Ne ponavljajte nalaze, interpretirajte ih** — Zaključak nije kopija Nalaza, nego njihovo značenje.
4. **Preporuku napišite konkretno** — umjesto «preporučuje se daljnja obrada» navedite koja pretraga i zašto.
5. **Kod hitnog nalaza zabilježite obavijest** — kome, u koliko sati i kojim putem je priopćen.

Vrste rečenica

OZNAKA	KADA	U OVOJ BANCI
NORMALNO	Bez patologije ili bez promjene; ograničenja procjene.	43 rečenice
NALAZ	Rutinski nalazi vezani uz kliničko pitanje.	82 rečenice
INCIDENTALNO	Incidentalni nalaz; uz preporuku opće korelacije ili praćenja.	26 rečenica
HITNO	Nalaz koji treba odmah javiti; uz evidenciju obavijesti.	49 rečenica

O intervalima praćenja

U rečenicama za incidentalne nalaze nisu navedeni interval praćenja ni granična veličina. Praćenje čvorova, lezija nadbubrežne žlijezde, cista i sličnih nalaza određuje se prema profilu rizika bolesnika i važećim smjernicama koje je prihvatila Vaša ustanova; ne upisujte u opis broj u koji niste sigurni, pitajte Vašeg mentora.

Uglate zagrade

[desno/lijevo], [.. mm], [vrijeme] i slična polja popunite, a neodgovarajuće opcije izbrišite. U opisu ne smiju ostati uglate zagrade.

POGLAVLJE 1

RTG

50 zaključaka, po sustavima.

RTG · Prsni koš

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
001	Na RTG snimci prsnog koša nije utvrđena akutna kardiopulmonalna patologija.	NORMALNO
002	U usporedbi s prethodnom pretragom bez značajne promjene.	NORMALNO
003	Na rendgenskoj snimci uz krevet nije prikazano novonastalo zasjenjenje, izljev ni pneumotoraks.	NORMALNO
004	Cijevi i kateteri u odgovarajućem su položaju; komplikacije vezane uz zahvat nisu prikazane.	NORMALNO
005	[Desno/Lijevo] [režanj] konsolidacija; uz klinički nalaz može odgovarati pneumoniji.	NALAZ
006	U usporedbi s prethodnom pretragom [desna donja zona] značajna regresija konsolidacije.	NALAZ
007	U usporedbi s prethodnom pretragom [desna donja zona] porast konsolidacije; preporučuje se klinička korelacija.	NALAZ
008	[Desno/Lijevo] [mala/umjerena/velika] količina pleuralnog izljeva.	NALAZ
009	Obostrano mala količina pleuralnog izljeva i bazalne pasivne atelektaze.	NALAZ
010	[Desno/Lijevo] [režanj] atelektaza; radi isključenja centralnog opstruktivnog uzroka po potrebi se preporučuje CT.	NALAZ
011	Bazalno linearne (pločaste) atelektaze.	NALAZ
012	Kardiomegalija (na PA snimci).	NALAZ
013	Zbog AP projekcije procjena veličine srca je ograničena.	NALAZ
014	Nalazi u prilog plućnog edema; preporučuje se klinička korelacija.	NALAZ
015	Znakovi plućne venske kongestije.	NALAZ
016	U usporedbi s prethodnom pretragom regresija znakova plućnog edema.	NALAZ
017	[Desno/Lijevo] pluća [zona]: [.. mm] ekspanzivna lezija; preporučuje se CT prsnog koša s kontrastom.	NALAZ
018	[Desno/Lijevo] [zona]: kavitarna lezija; radi infektivnih procesa i neoplazme preporučuju se klinička korelacija i CT.	NALAZ
019	Obostrano difuzna milimetarska nodularna zasjenjenja (milijarni uzorak); preporučuje se klinička i mikrobiološka korelacija.	NALAZ

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
020	Znakovi hiperinflacije; mogu odgovarati KOPB-u.	NALAZ
021	[Desno/Lijevo] [..]. rebro: prijelom; pneumotoraks nije prikazan.	NALAZ
022	Vrh endotrahealnog tubusa, u odnosu na karinu, [.. cm] iznad njega, u odgovarajućem položaju.	NALAZ
023	Vrh centralnog venskog katetera projicira se u gornju šuplju venu; pneumotoraks nije prikazan.	NALAZ
024	[Desno/Lijevo] [zona]: [.. mm] nodularno zasjenjenje; radi karakterizacije preporučuju se klinička korelacija i po potrebi CT.	INCIDENTALNO
025	Kalcificirane ateromatozne promjene aorte.	INCIDENTALNO
026	[Desno/Lijevo] pneumotoraks. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
027	[Desno/Lijevo] veliki pneumotoraks i radiološki znakovi tenzijskog pneumotoraksa. Hitni nalaz; [vrijeme] telefonski javljeno.	HITNO
028	Vrh endotrahealnog tubusa [desni glavni bronh] u projekciji. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
029	Vrh nazogastrične sonde [desni glavni bronh] u projekciji, nije u odgovarajućem položaju; prije uporabe [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
030	Izrazito proširenje medijastinuma; kod traume ili boli u prsima preporučuje se hitna CT angiografija zbog moguće patologije aorte. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

RTG · Abdomen

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
031	Na nativnoj snimci abdomena nisu utvrđeni nalazi u prilog opstrukcije ili slobodnog zraka.	NORMALNO
032	Raspodjela crijevnog plina je uobičajena.	NORMALNO
033	Nalaz odgovara opstrukciji tankog crijeva; preporučuje se CT abdomena s kontrastom.	NALAZ
034	Izraženi fekalni sadržaj u kolonu.	NALAZ
035	[Desno/Lijevo] [lokalizacija] u projekciji: denzitet koji može odgovarati kontrastnom kamencu; preporučuje se korelacija s UZV-om ili nativnim CT-om.	NALAZ
036	Kalcificirani denziteti u zdjelici koji mogu odgovarati flebolitima.	INCIDENTALNO
037	Slobodni zrak ispod ošita (pneumoperitoneum). Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
038	Nalaz govori u prilog volvulusa sigmoidnog kolona. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

RTG · Mišićno-koštani sustav

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
039	[Desno/Lijevo] [regija]: akutna koštana patologija nije utvrđena.	NORMALNO
040	Prijelom ni luksacija nisu prikazani; zglobni prostori su očuvani.	NORMALNO
041	Linija prijeloma nije prikazana; ako klinička sumnja perzistira, okultni prijelom ne može se isključiti RTG snimkom.	NORMALNO
042	[Desno/Lijevo] prijelom distalnog radijusa ([intraartikularni/ekstraartikularni], [dorzalno] s angulacijom).	NALAZ
043	[Desno/Lijevo] skafoid [slabinski] prijelom.	NALAZ
044	[Desno/Lijevo] [anteriorno] glenohumeralno iščašenje; nakon repozicije preporučuje se kontrolna snimka.	NALAZ
045	[Desno/Lijevo] [lateralni maleol] prijelom; maleolarna vilica [očuvan/proširen].	NALAZ
046	Poravnanje ulomaka prijeloma nakon repozicije [prihvatljiv/poremećen].	NALAZ
047	[Desno/Lijevo] koljeno: degenerativne promjene (osteoartritis); bez akutne koštane patologije.	NALAZ
048	Znak stražnjeg masnog jastučića; preporučuje se ortopedska procjena zbog mogućeg okultnog prijeloma.	NALAZ
049	[Kost]: [.. mm] litička lezija; radi karakterizacije preporučuju se klinička korelacija i daljnja obrada.	INCIDENTALNO
050	[Desno/Lijevo] prijelom vrata femura ([s pomakom/bez pomaka]). Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

POGLAVLJE 2

CT

70 zaključaka, po sustavima.

CT · Neuroradiologija

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
051	Nativnim CT-om mozga nije utvrđena akutna intrakranijalna patologija.	NORMALNO
052	Intrakranijalno krvarenje, učinak mase ni pomak središnje linije nisu prikazani.	NORMALNO
053	Rani ishemijski moždani udar ne mora se vidjeti na nativnom CT-u; ako klinička sumnja perzistira, može se razmotriti MR-DWI.	NORMALNO
054	U usporedbi s prethodnom pretragom nije prikazano novo krvarenje ni porast učinka mase.	NORMALNO
055	Cerebralna atrofija primjerena dobi; akutna patologija nije utvrđena.	NORMALNO
056	Periventrikularni hipodenziteti koji mogu odgovarati kroničnoj bolesti malih krvnih žila.	NALAZ
057	[Desno/Lijevo] [lokalizacija]: područje encefalomalacije koje odgovara kroničnom infarktu.	NALAZ
058	[Desno/Lijevo] [režanj] ekspanzivna lezija i vazogeni edem; preporučuje se MR mozga s kontrastom.	NALAZ
059	[Lokalizacija] nalaz odgovara sinusitisu.	NALAZ
060	[Desno/Lijevo] [kost] linearni prijelom; pridruženo intrakranijalno krvarenje nije prikazano.	NALAZ
061	[Lokalizacija]: ekstraaksijalna lezija s kalcifikacijama; može odgovarati meningeomu, preporučuje se korelacija s MR-om.	INCIDENTALNO
062	[Lokalizacija]: lezija denziteta likvora koja može odgovarati arahnoidnoj cisti.	INCIDENTALNO
063	[Desno/Lijevo] akutni epiduralni hematom; [.. mm] pomak središnje linije. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
064	[Desno/Lijevo] akutni subduralni hematom; prisutan je učinak mase. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
065	Subarahnoidalno krvarenje; radi isključenja aneurizme preporučuje se CT angiografija. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
066	[Desno/Lijevo] [lokalizacija] akutni intraparenhimski hematom, prodor u ventrikul [prisutan/odsutan]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
067	[Desno/Lijevo] Znakovi rane akutne ishemije u opskrbnom području MCA; nema krvarenja. U okviru protokola za moždani udar [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
068	[Desno/Lijevo] Znak hiperdenzne arterije u MCA; može biti u prilog akutnog tromba, preporučuje se CT angiografija. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
069	Nalazi u prilog akutnog opstruktivnog hidrocefalusa. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
070	[Subfalcina/Transtentorijska/Tonzilarna] znakovi hernijacije. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
071	[Desno/Lijevo] [kost] impresijski prijelom i ispod njega [ekstraaksijalno krvarenje]. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
072	Na CT angiografiji [desno/lijevo] [MCA M1] segment: okluzija. U okviru protokola za moždani udar [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

CT · Prsni koš

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
073	Na CT-u prsnog koša nije utvrđena značajna patologija.	NORMALNO
074	CT plućnom angiografijom nije utvrđena plućna tromboembolija.	NORMALNO
075	Zbog nedostatne opacifikacije plućnih arterija procjena na subsegmentnoj razini je ograničena.	NORMALNO
076	[Desno/Lijevo] [režanj] konsolidacija; može odgovarati infektivnom procesu.	NALAZ
077	Obostrana zasjenjenja tipa mliječnog stakla; u diferencijalnoj dijagnozi su infektivni i upalni procesi, preporučuje se klinička korelacija.	NALAZ
078	[Centrilobularni] emfizem.	NALAZ
079	Limfni čvorovi patološke veličine u medijastinumu; treba ih procijeniti ovisno o kliničkom kontekstu.	NALAZ
080	[Desno/Lijevo] u plućima [.. mm] ekspanzivna lezija i [hilarna/medijastinalna] limfadenopatija; radi tkivne dijagnoze preporučuje se klinička procjena.	NALAZ
081	[Desno/Lijevo] [režanj]: [.. mm] [solidna] čvor; potrebu za praćenjem treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema profilu rizika i važećim smjernicama.	INCIDENTALNO
082	Kalcifikacije koronarnih arterija.	INCIDENTALNO
083	Štitnjača [desno/lijevo] režanj: hipodenzni čvor; preporučuje se procjena UZV-om.	INCIDENTALNO
084	[Obostrano] akutna plućna tromboembolija; znakovi opterećenja desne klijetke [prisutan/odsutan]. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
085	[Zahvaća/ne zahvaća uzlaznu aortu] disekcija aorte. Hitni nalaz; kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
086	[Desno/Lijevo] pneumotoraks. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
087	Pneumomedijastinum; ako se klinički sumnja na perforaciju jednjaka, preporučuje se daljnja obrada. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
088	[Umjerena/Velika] količina perikardijalnog izljeva; radi tamponade preporučuje se hitna klinička i ehokardiografska procjena. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

CT · Abdomen i zdjelica

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
089	CT-om abdomena i zdjelice nije utvrđena akutna patologija.	NORMALNO
090	Apendiks urednog izgleda; nisu utvrđeni nalazi u prilog akutnog apendicitisa.	NORMALNO
091	Nativnim CT-om nisu utvrđeni konkrementi mokraćnog sustava ni hidronefroza.	NORMALNO
092	U usporedbi s prethodnom pretragom [lezija]: bez značajne promjene.	NORMALNO
093	[Sigmoidni kolon] akutni nekomplicirani divertikulitis kolona.	NALAZ
094	[Desno/Lijevo] [distalno] u ureteru [.. mm] kamenac i [blaga] hidroureteronefroza.	NALAZ
095	Akutno [intersticijski edematozni] znakovi pankreatitisa.	NALAZ
096	Nalazi u prilog akutnog kolecistitisa; preporučuje se korelacija s UZV-om.	NALAZ
097	Kolelitijaza; nisu prikazani nalazi u prilog akutnog kolecistitisa.	NALAZ
098	Brojne lezije u jetri koje mogu odgovarati metastazama; preporučuje se klinička i po potrebi patohistološka korelacija.	NALAZ
099	Steatoza jetre.	NALAZ
100	[Mala/Umjerena] količina ascitesa.	NALAZ
101	[Lokalizacija] zadebljanje stijenke kolona; diferencijalna dijagnoza uključuje upalne, infektivne i neoplastične uzroke, preporučuje se endoskopska korelacija.	NALAZ
102	Segment jetre [..]: lezija koja odgovara jednostavnoj cisti.	INCIDENTALNO
103	[Desno/Lijevo] u bubregu lezija koja odgovara jednostavnoj cisti.	INCIDENTALNO
104	[Desno/Lijevo] čvor nadbubrežne žlijezde; karakterizaciju i praćenje treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema važećim smjernicama.	INCIDENTALNO
105	[Desno/Lijevo] u bubregu [.. mm] lezija koju nije moguće karakterizirati; za daljnju procjenu [dinamički CT/MR] se preporučuje.	INCIDENTALNO
106	U jetri ovom pretragom nekarakterizirana [.. mm] hipodenzna lezija; po potrebi se preporučuje procjena dinamičkim MR-om.	INCIDENTALNO
107	Nalazi koji odgovaraju akutnom apendicitisu. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
108	Akutni apendicitis i [periapendikularni apsces/perforacija] znakovi. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
109	Pneumoperitoneum; [moguća lokalizacija] u prilog perforacije. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
110	Zona prijelaza [regija]: nalaz govori u prilog mehaničke opstrukcije tankog crijeva i ishemije. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
111	Aneurizma abdominalne aorte i periaortalni hematom u prilog rupture. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
112	Ozljeda slezene, hemoperitoneum i aktivna ekstravazacija kontrasta. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
113	Pneumatoza stijenke crijeva i plin u portalnoj veni; preporučuje se hitna klinička procjena zbog moguće mezenterijske ishemije. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
114	[Desno/Lijevo] opstruktivni kamenac uretera i [perirenalna kolekcija/emfizematozna promjena]; ako se klinički sumnja na inficiranu opstrukciju, preporučuje se hitna procjena. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

CT · Kralježnica i mišićno-koštani sustav

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
115	CT-om vratne kralježnice nije utvrđena akutna traumatska koštana patologija.	NORMALNO
116	Ligamentarna ozljeda ne može se CT-om potpuno isključiti; ako postoje neurološki nalazi, preporučuje se MR.	NORMALNO
117	[L1] kralježak: kompresijski prijelom akutnog izgleda; suženje spinalnog kanala nije prikazano.	NALAZ
118	Degenerativne promjene lumbalnih kralježaka.	NALAZ
119	[Kralježak] u tijelu kralješka sklerotično žarište; može odgovarati koštanom otočiću, preporučuje se klinička korelacija.	INCIDENTALNO
120	[Razina] na toj razini prijelom/iščašenje nestabilnog izgleda i suženje spinalnog kanala. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

POGLAVLJE 3

MR

35 zaključaka, po sustavima.

MR · Neuroradiologija

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
121	Na MR-u mozga nije utvrđena značajna patologija.	NORMALNO
122	Na DWI nije utvrđena restrikcija difuzije u prilog akutnog infarkta.	NORMALNO
123	Nakon kontrasta nije prikazana patološka imbibicija.	NORMALNO
124	U usporedbi s prethodnom pretragom nisu prikazane nove lezije ni lezije koje se imbibiraju kontrastom.	NORMALNO
125	Promjene bijele tvari koje mogu odgovarati kroničnoj bolesti malih krvnih žila; nema akutnog infarkta.	NALAZ
126	Lezije bijele tvari koje mogu odgovarati demijelinizacijskoj bolesti; treba ih procijeniti uz kliničku sliku i važeće dijagnostičke kriterije.	NALAZ
127	[Regija]: ekstraaksijalna masa koja odgovara meningeomu.	NALAZ
128	Hipofiza [mikro/makro] lezija koja odgovara adenomu; preporučuje se endokrinološka korelacija.	NALAZ
129	[Desno/Lijevo] [režanj] intraaksijalna masa s prstenastom imbibicijom kontrastom; u diferencijalnoj dijagnozi prvenstveno se razmatraju glijalni tumor visokog stupnja i metastaza.	NALAZ
130	Cistična lezija koja može odgovarati pinealnoj cisti.	INCIDENTALNO
131	[Lokalizacija]: izgled koji odgovara razvojnoj venskoj anomaliji.	INCIDENTALNO
132	[Desno/Lijevo] [arterija] područje opskrbe: akutni infarkt. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
133	Nalazi koji odgovaraju apscesu mozga. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
134	[Sinus] tromboza. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
135	Akutno krvarenje unutar lezije hipofize i kompresija optičke kijazme; preporučuje se hitna klinička procjena zbog moguće apopleksije. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

MR · Kralježnica

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
136	Na MR-u lumbalne kralježnice nije utvrđena značajna patologija.	NORMALNO

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
137	Osim degeneracije diska nisu utvrđeni znakovi značajne kompresije.	NORMALNO
138	L [4-5] [desno paramedijalno] ekstruzija diska; [L5] pritisak na živčani korijen.	NALAZ
139	C [5-6] kompleks disk-osteofit i [desno] foraminalno suženje; bez promjene signala moždine.	NALAZ
140	[L1] kralježak: [akutni/subakutni] kompresijski prijelom; znakovi patološkog prijeloma nisu prikazani.	NALAZ
141	[Kralježak] u tijelu kralješka lezija koja odgovara tipičnom hemangiomu.	INCIDENTALNO
142	[Razina] u razini lezija koja može odgovarati epiduralnom širenju tumora i kompresija leđne moždine. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO
143	[Razina] na toj razini velika ekstruzija diska i izražen pritisak na korijene caude equine; preporučuje se hitna procjena zajedno s kliničkim nalazom. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

MR · Mišićno-koštani sustav

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
144	[Desno/Lijevo] koljeno: na MR-u nije utvrđena značajna patologija.	NORMALNO
145	[Cijele debljine] ruptura ACL-a i [lateralni odjeljak] koštane kontuzije.	NALAZ
146	[Medijalno] meniskus [stražnji rog] [kosa] ruptura.	NALAZ
147	U tetivi m. supraspinatusa [cijele debljine] ruptura; retrakcija [.. mm].	NALAZ
148	[Desno/Lijevo] avaskularna nekroza glave femura; kolaps zglobne površine nije prikazan.	NALAZ
149	Poplitealna (Bakerova) cista; bez znakova rupture.	NALAZ
150	[Regija]: zahvaćenost koštane srži i [subperiostalno/mekotkivno] kolekcija; radi osteomijelitisa i apscesa preporučuje se hitna klinička procjena. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

MR · Abdomen i zdjelica

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
151	Dinamičkim MR-om jetre nije utvrđena fokalna lezija.	NORMALNO
152	Segment jetre [..]: lezija koja odgovara tipičnom hemangiomu.	NALAZ
153	Konkrement u distalnom koledokusu (koledokolitijaza) i dilatacija žučnih vodova.	NALAZ
154	[Desno/Lijevo] u jajniku lezija koja odgovara jednostavnoj cisti; potrebu za praćenjem treba odrediti klinički tim.	INCIDENTALNO
155	U gušterači [.. mm] cistična lezija; karakterizaciju i praćenje treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema važećim smjernicama.	INCIDENTALNO

POGLAVLJE 4

UZV / Doppler

45 zaključaka, po sustavima.

UZV / Doppler · Abdomen

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
156	Na UZV-u cijelog abdomena patologija nije utvrđena.	NORMALNO
157	Žučni mjehur urednog izgleda; nisu prikazani konkrementi ni znakovi akutnog kolecistitisa.	NORMALNO
158	Intrahepatalni i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani.	NORMALNO
159	Slobodna tekućina u abdomenu nije prikazana.	NORMALNO
160	Zbog crijevnog plina procjena gušterače je ograničena.	NORMALNO
161	Kolelitijaza; nisu prikazani nalazi u prilog akutnog kolecistitisa.	NALAZ
162	Žučni mulj (sludge).	NALAZ
163	[Blaga/Umjerena/Izražena] izgled koji odgovara steatozi jetre.	NALAZ
164	Gruba ehostruktura i nodularna kontura koje mogu odgovarati kroničnoj bolesti parenhima jetre.	NALAZ
165	Splenomegalija.	NALAZ
166	Dilatacija koledokusa; ako uzrok nije utvrđen, preporučuje se MRCP.	NALAZ
167	[Mala/Umjerena/Velika] količina ascitesa.	NALAZ
168	Segment jetre [..]: hiperehogena lezija koja može odgovarati hemangiomu; ovisno o kliničkom kontekstu preporučuje se daljnja obrada.	INCIDENTALNO
169	U žučnom mjehuru [.. mm] polip; potrebu za praćenjem treba odrediti prema važećim smjernicama.	INCIDENTALNO
170	Nalazi koji odgovaraju akutnom kalkuloznom kolecistitisu. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
171	Nalazi koji odgovaraju akutnom apendicitisu. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
172	[Ileokolična] nalazi odgovaraju invaginaciji. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
173	Segment jetre [..]: lezija koja može odgovarati apscesu. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO

UZV / Doppler · Urogenitalni sustav i zdjelica

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
174	Na UZV-u mokraćnog sustava patologija nije utvrđena.	NORMALNO
175	Na skrotalnom dopplerskom UZV-u testikularni protok obostrano je simetričan; patologija nije utvrđena.	NORMALNO
176	[Desno/Lijevo] [blaga/umjerena] hidronefroza; [mogući uzrok].	NALAZ
177	[Desno/Lijevo] u bubregu [.. mm] kamenac; bez hidronefroze.	NALAZ
178	[Desno/Lijevo] nalaz odgovara epididimoorhitisu; testikularni protok je očuvan.	NALAZ
179	[Desno/Lijevo] jednostavna kortikalna cista bubrega.	INCIDENTALNO
180	Prostata [povećan]; preporučuje se klinička korelacija.	INCIDENTALNO
181	[Desno/Lijevo] nalazi odgovaraju torziji testisa. Hitni nalaz; [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
182	Intrauterina trudnoća nije prikazana; uz adneksalnu masu i slobodnu tekućinu nalaz govori u prilog izvanmaternične trudnoće. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

UZV / Doppler · Vaskularno

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
183	[Desno/Lijevo] u dubokim venama donjih ekstremiteta tromboza nije utvrđena.	NORMALNO
184	U obje karotidne arterije nisu utvrđeni nalazi u prilog hemodinamski značajne stenoze.	NORMALNO
185	[Desno/Lijevo] [unutarnja karotidna] aterosklerotski plak u arteriji; stupanj stenoze prema kriterijima ustanove [stupanj].	NALAZ
186	[Desno/Lijevo] nalaz odgovara površinskoj venskoj trombozi; duboki venski sustav je prohodan.	NALAZ
187	U usporedbi s prethodnom pretragom u trombu [rekanalizacija/bez promjene].	NALAZ
188	U infrarenalnoj abdominalnoj aorti [.. mm] proširenje; potrebu za praćenjem treba odrediti zajedno s kliničkim timom.	INCIDENTALNO
189	[Desno/Lijevo] [femoropoplitealna] segment: akutna duboka venska tromboza. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
190	U simptomatskog pacijenta [.. mm] aneurizma abdominalne aorte; rupturu nije moguće isključiti UZV-om, preporučuje se hitna CT angiografija. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

UZV / Doppler · Vrat i površinska tkiva

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
191	Na UZV-u štitnjače patologija nije utvrđena.	NORMALNO
192	Na vratu nisu utvrđeni limfni čvorovi patološkog izgleda.	NORMALNO

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
193	Štitnjača [desni režanj]: [.. mm] čvor; prema stratifikaciji rizika Vaše ustanove [kategorija].	NALAZ
194	Heterogena ehostruktura koja može odgovarati difuznoj bolesti parenhima štitnjače; preporučuje se korelacija s testovima funkcije štitnjače.	NALAZ
195	[Regija]: kolekcija koja odgovara apscesu mekih tkiva i znakovi okolnog celulitisa.	NALAZ
196	[Desno/Lijevo] u dojci lezija koja odgovara jednostavnoj cisti.	INCIDENTALNO

UZV / Doppler · POCUS i eFAST

BR.	ZAKLJUČAK / DOJAM	VRSTA
197	Na eFAST-u nisu utvrđeni znakovi slobodne tekućine, perikardijalnog izljeva ni pneumotoraksa. Negativan eFAST ne isključuje ozljedu organa.	NORMALNO
198	Obostrano difuzne B-linije; odgovara intersticijskom sindromu.	NALAZ
199	FAST pozitivan: [U Morisonovu džepu] slobodna tekućina. Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.	HITNO
200	[Desno/Lijevo] klizanje pluća nije prikazano, a utvrđena je plućna točka; nalaz govori u prilog pneumotoraksa. [Vrijeme]: priopćeno.	HITNO

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Bonus 2 · 50 pogrešaka u opisu koje Vaš mentor najčešće ispravlja. Naučili ste odabrati ispravan zaključak; sada prepoznajte pogreške zbog kojih se opis vraća i nemojte ih više ponavljati.

Da biste rečenice vidjeli unutar cjelovitog opisa **Glavni materijal · 120 predložaka gotovih opisa** se možete vratiti.